

Behandeling spierinvasieve blaaskanker

De behandeling bij spierinvasieve blaaskanker hangt af van het stadium en subtype van de ziekte. De standaardbehandeling is vier kuren (neoadjuvante) chemotherapie en daarna een blaasverwijdering (cystectomie). Soms is een blaassparende behandeling mogelijk met bestraling (uitwendig of inwendig), vaak gecombineerd met chemotherapie. Of brachytherapie (inwendige bestraling), maar dat kan alleen bij kleine blaastumoren.

“Immuuntherapie heeft ook hier een plaats gekregen”, stelt Ronald de Wit. Bij spierinvasieve blaaskanker mag immuuntherapie worden gegeven als de ziekte na eerdere behandeling met chemotherapie terugkeert. Voor deze tweedelijsbehandeling zijn verschillende immuuntherapieën geregistreerd, onder meer pembrolizumab, nivolumab, durvalumab, atezolizumab en avelumab. Hij vervolgt: “In Nederland wordt meestal de immuuntherapie pembrolizumab gegeven. Immuuntherapie werkt echter maar bij ongeveer één op de drie patiënten, maar als het werkt dan werkt het vaak heel langdurig.”

Immuuntherapie is in Nederland ook geregistreerd bij de behandeling van uitgezaaide blaaskanker als patiënten die wenselijke cisplatin-bevattende chemotherapie niet kunnen verdragen, meestal door verminderde nierfunctie. Tot voor kort was er voor deze patiëntengroep dan alleen nog een behandeling met carboplatin beschikbaar.

“Maar carboplatin is minder goed dan cisplatin”, benadrukt Ronald de Wit. “Uit KEYNOTE 052 weten we dat patiënten met uitgezaaide blaaskanker die de immuuntherapie als eerste behandeling krijgen, dus voor carboplatin, ook baat kunnen hebben bij immuuntherapie.”

Ontwikkelingen spierinvasieve blaaskanker

In KEYNOTE 052 werd gezocht naar aanwijzingen op de blaaskanker of dat er een kans was dat immuuntherapie zou aanslaan. De zogenaamde PD-L1 test.

“Als op de tumorcellen de PD-L1 kleuring positief was dan zagen we dat de mediane overleving 18,5 maand was. Dat is echt wel een verschil ten opzichte van het effect van carboplatin-gemcitabine. Want daarbij is de overleving gemiddeld 9 maanden. Deze twee middelen zijn nog niet direct met elkaar vergeleken. Maar ik denk dat het wel heel vergelijkbare patiëntengroepen waren. Dus als je kijkt naar gemiddelde leeftijd, conditie en waar de uitzaaiingen zaten. Dan is het denk ik wel reëel om de gegevens zo naast elkaar te leggen.”

In een aantal ziekenhuizen in Nederland loopt de LEAP-011-studie. Dit betreft een eerstelijsbehandeling van gevorderd of uitgezaaid urotheelcelcarcinoom voor patiënten die cisplatin niet kunnen verdragen. In deze studie krijgen alle patiënten de immuuntherapie pembrolizumab en de helft van de patiënten krijgt er nog een ander middel bij. Dat andere middel is lenvatinib, een angiogeneseremmer.

“De verwachting is dat de angiogeneseremmer het effect van de immuuntherapie zal versterken”, licht Ronald de Wit toe. “In deze studie krijgt iedereen immuuntherapie, dus de meer kansrijke behandeling dan de chemotherapie carboplatin-gemcitabine.”

Er is ook onderzoek gaande naar de toevoeging van immuuntherapie aan de neoadjuvante chemotherapie. Dus voorafgaand aan de blaasverwijdering. Een voorbeeld hiervan is de NIAGARA-studie. Ook wordt onderzocht of immuuntherapie de uitkomst verbetert van blaassparende behandelingen met bestraling en chemotherapie, zoals in de KEYNOTE 992.